NOTA INFORMATIVA

Asunto: Articulación del Programa Salud Casa por Casa con los Centros Coordinadores de Salud para el Bienestar

Dirigido a: Programa Salud Casa por Casa
Secretaría del Bienestar

De: Servicio Nacional de Salud Pública
Centros Coordinadores de Salud para el Bienestar

1. Acerca de los Centros Coordinadores de Salud para el Bienestar

Los Centros Coordinadores de Salud para el Bienestar (CeCoSaBi) son una estrategia operativa del SNSP orientada a articular, dar seguimiento y facilitar la continuidad de la atención de personas que enfrentan barreras de acceso a los servicios de salud, mediante un enfoque territorial, comunitario y centrado en la persona.

Su labor se enfoca en:

- Identificar barreras geográficas, administrativas y económicas que limitan el acceso efectivo.
- Colaborar con los servicios estatales en la coordinación de la referencia, contrarreferencia y acompañamiento de casos prioritarios.
- Dar seguimiento a trayectorias de atención complejas en articulación con instituciones prestadoras de servicios de salud.
- Generar información sobre las barreras de acceso y trayectorias de atención para la toma de decisiones y la mejora de los procesos de atención.

2. Propósito de la vinculación y valor agregado que aporta el CeCoSaBi

Este enfoque es complementario y de apoyo al trabajo comunitario que realiza el Programa Salud Casa por Casa, por lo que los objetivos de la vinculación se enfocan en establecer un mecanismo operativo único para que los equipos de Casa por Casa canalicen y den seguimiento a casos prioritarios mediante CeCoSaBi, asegurando:

- Disminución de pérdidas en referencia/contrarreferencia.
- Fortalecer la continuidad de la atención en salud posterior a la visita domiciliaria.
- Asegurar el seguimiento de casos prioritarios hasta su resolución con retroalimentación al territorio.
- Reducir pérdidas en la referencia y contrarreferencia.

3. Actividades de seguimiento para la participación de los Centros Coordinadores de Salud para el Bienestar

En el marco de la colaboración con el Programa Salud Casa por Casa, los CeCoSaBi pueden asumir actividades específicas de seguimiento, gestión y articulación **a distancia orientadas a contribuir con la continuidad** para los siguientes cuatro tipos de pacientes prioritarios y un componente transversal de prescripción social:

1) Personas con riesgo o sospecha de cáncer de la mujer (Mama y cáncer cervicouterino)

- Seguimiento a la referencia oportuna a servicios diagnósticos.
- Identificación de barreras que retrasen el acceso y promoción de la prescripción social para su mitigación.
- Acompañamiento en la continuidad del proceso diagnóstico y de atención inicial y el seguimiento de la trayectoria.

2) Personas en situaciones de abandono y postración clasificadas por el Programa Salud Casa por Casa que requieren intervención por instituciones prestadoras de servicios de salud

- Reforzar la coordinación con unidades de segundo o tercer nivel para programar su atención.
- Seguimiento a la aceptación, programación y resolución del caso.
- Retroalimentación al equipo comunitario sobre el estatus del paciente.

3) Personas con trayectorias de atención compleja. (Casos con múltiples abordajes previos no exitosos)

- Revisión integral de la trayectoria de atención.
- Identificación de puntos críticos y barreras persistentes que representan obstáculos para la conclusión de la gestión.
- Gestión interinstitucional e intersectorial para redefinir rutas de atención más efectivas.

4) Pacientes que representaron una urgencia y requiere seguimiento posterior

- Verificación de la continuidad de la atención posterior al evento urgente.
- Seguimiento a indicaciones médicas y referencias subsecuentes.
- Dotar de información para colaborar con los servicios para prevenir reingresos evitables.

5) Pacientes de cualquiera de las cuatro categorías que requieran medidas de prescripción social, que incluye el seguimiento para el acceso a diferentes activos comunitarios como:

- Apoyos económicos básicos
- Apoyo emocional y social
- Insumos de apoyo para la movilidad y la rehabilitación.

Esta colaboración contribuye a consolidar un modelo de atención más integral e integrado, resolutivo y centrado en las personas, particularmente en poblaciones con mayores barreras de acceso.